

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 DNA合成を障害	フッ化ピリミジン系 5-FU カペシタビン S-1 FTD/TPI 白金製剤 オキサリプラチン トポイソメラーゼII阻害薬 イリノテカン
血管新生阻害薬 腫瘍血管の新生を阻害	抗VEGF抗体 ベバシズマブ 抗VEGFR-2抗体・VEGF捕捉 ラムシルマブ アフリベルセプト ベータ 経口VEGFR阻害薬 レゴラフェニブ フルキンチニブ
増殖シグナル阻害薬 EGFR・BRAF・HER2経路を遮断	抗EGFR抗体(RAS野生型) セツキシマブ パニツムマブ BRAF/MEK阻害薬 エンコラフェニブ ビニメチニブ 抗HER2抗体 トラスツマブ ペルツマブ
免疫チェックポイント 阻害薬 MSI-High/dMMRに使用	抗PD-1抗体 ペムブロリズマブ ニボルマブ 抗CTLA-4抗体 イピリムマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(切除不能進行・再発)

バイオマーカー・原発部位	1次治療	2次治療	3次治療以降
RAS野生型・左側	FOLFOX/FOLFIRI+抗EGFR抗体	1次と異なる化学療法+抗VEGF薬	レゴラフェニブ FTD/TPI±ベバシズマブ フルキンチニブ
RAS変異型・右側	FOLFOX/CAPOX/FOLFIRI+ベバシズマブ	FOLFIRI+抗VEGF薬(ベバシズマブ等)	同上
BRAF V600E変異	FOLFOXIRI+ベバシズマブ等	エンコラフェニブ+セツキシマブ(±ビニメチニブ)	同上
MSI-High(dMMR)	ペムブロリズマブ等	化学療法+分子標的薬	同上

1次治療で使わなかった薬剤を後のラインで使うのが基本。3次治療以降は経口薬が中心となり、保険薬局の関わりが大きい。

3 副作用の特徴と発現時期

作用機序から予測:抗VEGF薬=血圧・蛋白尿・出血、抗EGFR抗体=皮疹・低Mg血症、イリノテカン=下痢・UGT1A1、オキサリプラチン=しびれ

	投与日	1週	2週	3週	4週	2か月～
● 急性神経症状(オキサリプラチン)	● 投与中～数日					
● 早発性下痢(イリノテカン)	● 投与中～24時間					
● 遅発性下痢(イリノテカン)	● 投与後数日～					
● 好中球減少(nadir)		● 7～14日目				
● 皮疹様皮疹(抗EGFR抗体)		● 1～2週で出現、数週でピーク				
● 手足症候群(カペシタビン等)		● 数週～(レゴラフェニブは1か月以内に多い)				
● 低Mg血症(抗EGFR抗体)					● 数週～数か月	
● 蓄積性の末梢神経障害						● 累積投与量に依存

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 原発部位とRAS・BRAF・MSI・HER2で1次治療が決まり、未使用の薬剤を後のラインで使う
2. UGT1A1多型ではイリノテカンの下痢・好中球減少が重篤化しやすい。結果を薬歴に記録する
3. 経口薬の服用日管理・携帯型ポンプ抜針後のフォロー・Gradeでの情報共有が薬局の強み